

LES EFFETS INDÉSIRABLES DES MÉDICAMENTS

I. INTRODUCTION

Chaque médicament peut entraîner un ou plusieurs effet(s) nocifs(s) qui doivent être connus par le médecin avant sa prescription et par le pharmacien avant sa dispensation

Ces effets sont généralement mineurs par rapport aux bénéfices apportés par le traitement (la balance bénéfice/ risque

**Les effets
toxiques**

**Les effets
indésirables**

NOTE

II. LES EFFETS INDÉSIRABLES

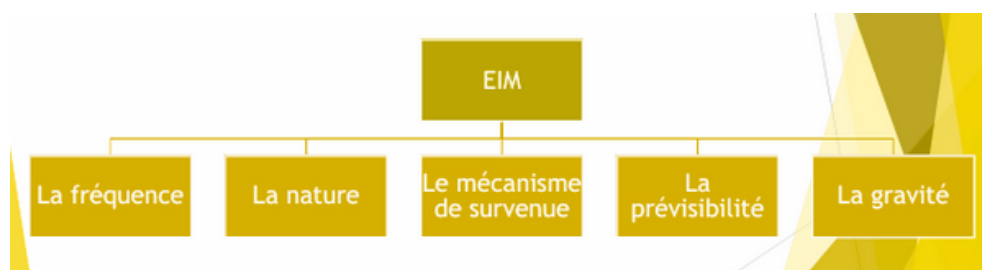
1. Définition

Un effet indésirable est une réaction nocive et non voulue se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou la modification d'une fonction physiologique.

C'est également toute réaction résultant d'un:

- Mésusage
- Usage abusif
- Pharmacodépendance (Syndrome de sevrage)
- Inefficacité thérapeutique
- Produit défectueux ou de mauvaise qualité

2. Classification des effets indésirables



2.1 Classification des EIM selon la fréquence

Type EIM	La fréquence de survenue
Très fréquent	$\geq 1/10$ ($\geq 10\%$)
Fréquent	$\geq 1/100$ et $< 1/10$ (1%-10%)
Peu fréquent	$\geq 1/1000$ et $< 1/100$ (0.1%-1%)
Rare	$\geq 1/10000$ et $< 1/1000$ (0.01%- 0.1%)
Très rare	$< 1/10000$ ($< 0.01\%$)

NOTE

2.2 Classification des EIM selon la nature

Spécificité d'organe

NOTE

Hépatique

- Rifampicine
- Isoniazide

Rénale

- Vancomycine
- Aminoglycosides

Gastro-intestinale

- AINS
- Cytotoxique

2.3 Classification des EIM selon la gravité

GRAVE

- nécessite une hospitalisation OU
- provoque un handicap/incapacité OU
- se traduit par une anomalie congénitale OU
- met en danger la vie OU
- entraîne la mort

SEVERE

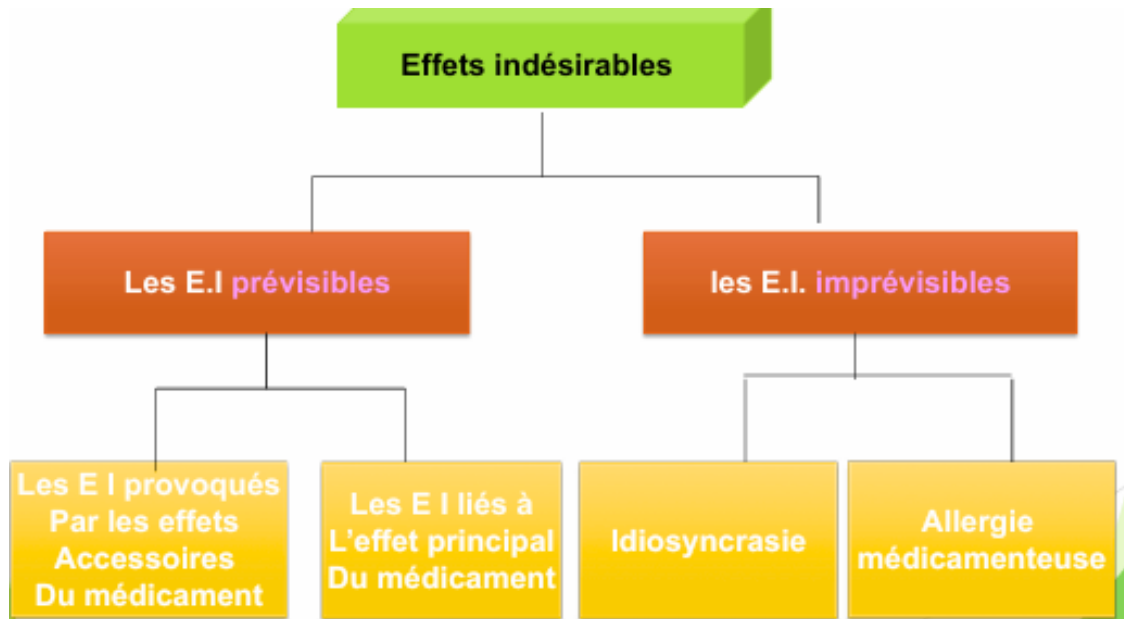
- Nécessite en plus de l'arrêt du traitement des soins supplémentaires

**MODERE
(BANAL)**

- Ni sévère, ni grave.

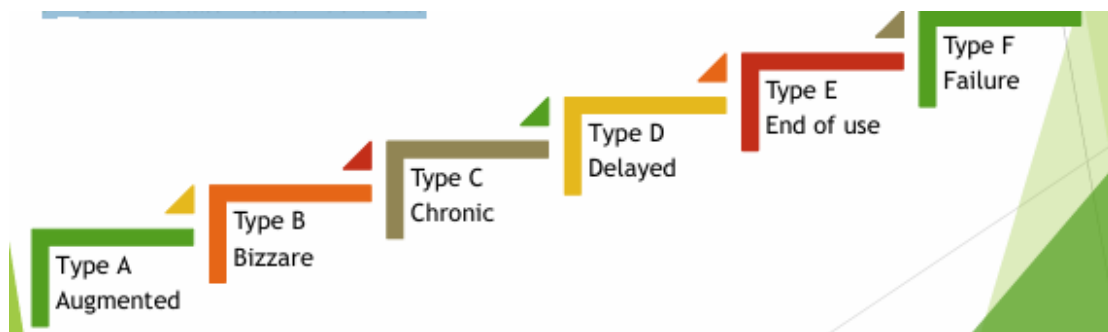
2.4 Classification des EIM selon la prévisibilité

2.4 Classification des EIM selon la prévisibilité



2.5 Classification des EIM selon le mécanisme

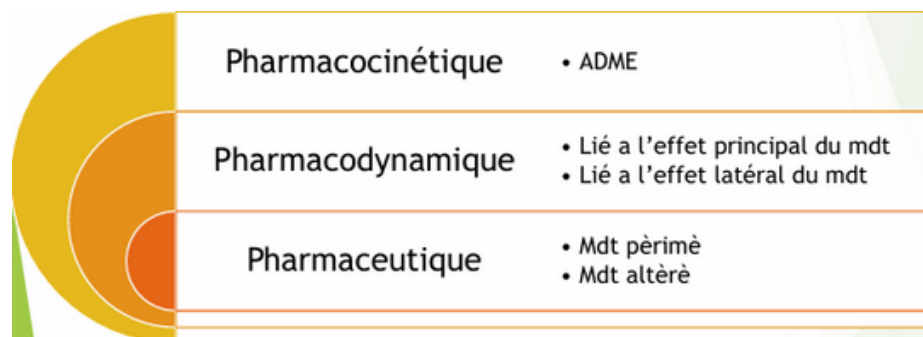
- u Meilleure compréhension des EIM
- u Préconiser une conduite à tenir adaptée / EIM
- u Prévenir les EIM
- u C'est la classification de l'OMS



2.5.1 Effet indésirable médicamenteux de type A

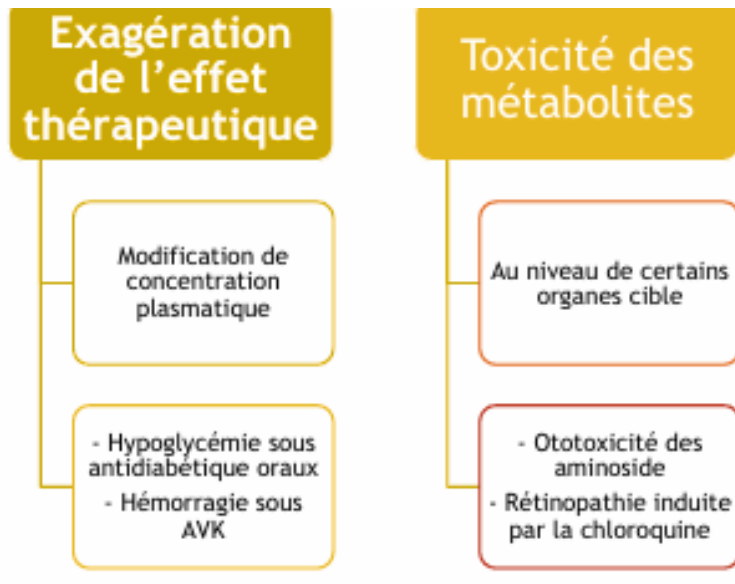
- u Pharmacologique : effets catégoriels c à d qui sont directement liés à l'effet principal du médicament
- u Leur survenue est liée à une des propriétés pharmacologiques du médicament.
- u Ils sont assez fréquents, généralement connus des essais cliniques, donc avant l'autorisation de mise sur le marché (AMM)

Mécanisme



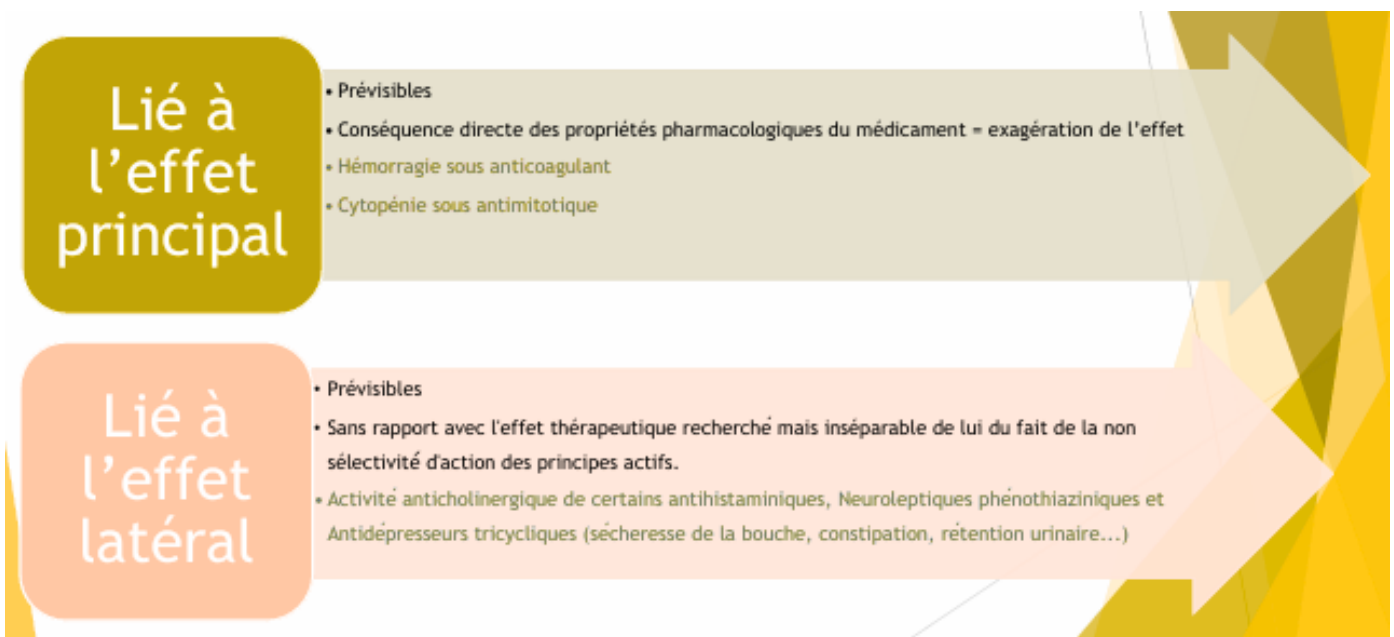
PHARMACOCINÉTIQUE

Ces perturbations aboutissent à un effet Toxique du Médicament en rapport avec une



- FACTEURS DE RISQUES: Enfant/ sujet âgé/ Insuffisance Renale/ Insuffisance Hépatique/ Interactions.

PHARMACODYNAMIE

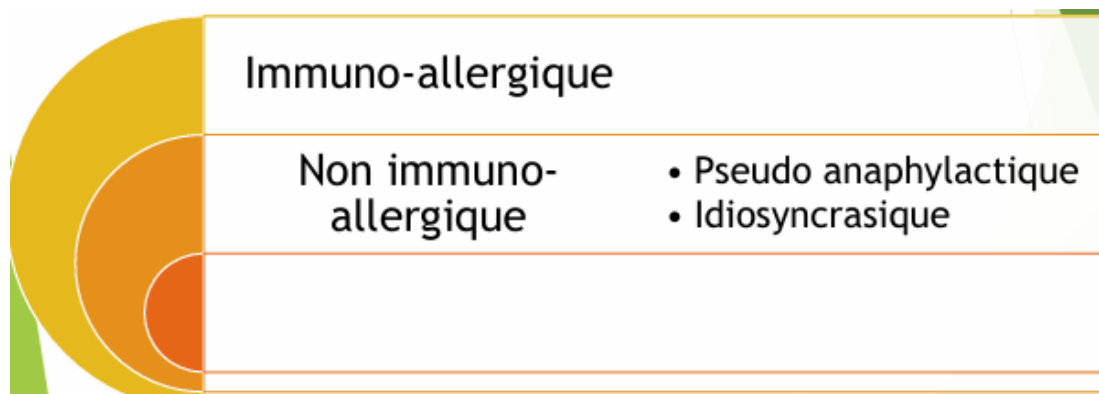


Pharmaceutique

- u Produit périmé, altéré → Inefficacité, Toxicité Exemple: toxicité des tétracyclines périmées: syndrome de Fanconi
- u Modification des paramètres de libération du produit Perte du caractère de « libération prolongée » de certaines formes pharmaceutiques

2.5.2 Effet indésirable médicamenteux de type B

Mécanisme



Réaction immuno-allergique

- Prévion quasi impossible avant AMM (essais precliniques, essais cliniques).
- éactions d'hypersensibilite(de type I II III ou IV).
- N'ont aucun rapport avec les propriétés pharmacologiques du médicament.
- Nécessite une sensibilisation de plusieurs jours Immédiate
(**rhinite, toux, conjonctivite**) / **retardé(eczéma)**
- u La ré administration du médicament entraine des réaction encore plus grave

Réactions pseudo-anaphylactiques

- Réaction similaire aune réaction allergique due ala libération directe d'histamine secondaire ala degranulation des basophiles, sans réaction Ag-Ac, donc en l'absence de sensibilisation préalable
- Les médicaments les plus souvent impliqués dans ce type de réaction sont :
 - 1.L'aspirine (syndrome de stevens-Johnson).
 - 2.produits de contraste radiologique.
 - 3.Les curares.
 - 4.Les anesthésiques généraux

Réactions idiosyncrasiques:

L'idiosyncrasie est une reactiviteanormale au medicament, d'origine genetique (innee), inattendue et resultant d'une predisposition particuliere du sujet.

- u Reaction qualitativement anormale (genetiquement determinee).
- u Reaction non liee aune action pharmacologique.
- u Reaction ressemble aune hypersensibilite, mais n'implique pas un mecanisme immunologique.
- u Reactions pour lesquelles le mecanisme n'est pas toujours clair.

- u Hyperthermie maligne sous anesthésie générale
- u Anémie hémolytique sous Primaquine.
- u Hyperplasie gingivale à la phénytoïne

2.5.3 Effet indésirable médicamenteux de type C

- Augmentation de la fréquence d'une maladie spontanée survenant après la prise chronique
- D'un médicament Mécanisme souvent indéterminé
- Lié à une dose cumulative
- u Apparition de Cancers du sein sous contraceptifs oraux.
- u Accidents thrombo-emboliques et calculs biliaires sous contraceptifs oraux.
- u Cardiotoxicité après la prise d'anthracycline

2.5.3 Effets indésirables médicamenteux de type D /E/F

Type d'effet		Signification	caractéristiques	exemple
D	Delayed	Temps dépendant	- Rare - Souvent dose dépendant - Apparaît à distance de prise	- Atteintes des valves cardiaques sous amphétamines
E	End of use	Par arrêt	- Rare - apparaît en cas d'arrêt brutal du traitement	- Effet rebond après arrêt d'un bêta bloquant
F	Failure	Par échec	- Courant - Dose dépendant - Souvent la résultante d'une interaction	- Inefficacité d'un contraceptif oral lors de la prise de millepertuis

